

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000735-02.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAICON DIAS

MEDIDA DE URGÊNCIA. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5000735-02.2025.4.02.5101

510015489273 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000735-02.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAICON DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face da decisão de evento 28, DESPADEC1 dos autos originários que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam ao autor o tratamento de Oxigenoterapia Domiciliar, nas modalidades estacionária e portátil, com os acessórios apontados nos documentos médicos acostados aos autos.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, sob o fundamento da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de redirecionamento da decisão ao ente municipal, tendo em vista este possuir a infraestrutura adequada para o célere cumprimento da tutela.

Sustenta, ainda, não poder ser considerada a responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde, requerendo todos os ônus financeiros sejam custeados igualmente pelos corréus.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional,

garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em juízo perfunctório, verifico a presença do fumus boni iuris, na medida em que o laudo médico (evento 26, LAUDO6) informa que o recorrido é portador de neoplasia maligna com nefrectomia direita prévia e metástase pulmonar, necessitando de oxigenoterapia domiciliar contínua para manter níveis mínimos de oxigenação sanguínea.

O parecer do NAT de evento 24, PARECER1, ratifica os laudos apresentados, enfatizando que a suplementação de oxigênio domiciliar está indicada para o quadro clínico do autor, porém, sem possibilidade de acesso gratuito na via administrativa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Também não há informações acerca do fornecimento do insumo diretamente pelo município, de modo que a tutela jurisdicional é a única forma de o autor conseguir realizar seu tratamento de extrema importância para manutenção de sua vida, já que manteve-se internado com queixa de dispneia progressiva.

No tocante ao periculum in mora, também o reputo presente, pois não se revela razoável que o recorrido mantenha-se frequentemente internado até que seja proferida decisão em cognição exauriente, quando lhe é clinicamente possível manter seu tratamento em casa. Obviamente que na atual condição do autor, permanecer internado seria ainda mais prejudicial ao seu gravíssimo quadro clínico, haja vista a própria natureza da enfermidade acometida e o risco de insuficiência respiratória.

Portanto, reputo presentes cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC, destacando que o autor não está em condições laborais, de modo que não possui meios de arcar com os elevados custos do tratamento de forma particular.

Por fim, ressalto que o Pretório Excelso possui pacífico entendimento no sentido de que a responsabilidade pela tutela do direito fundamental à saúde é de todos os entes federados de maneira solidária, logo, eventuais normas infralegais que estabeleçam atribuições administrativas distintas a cada um dos entes, não podem se sobrepor ao entendimento do STF, nem ao que dispõe a Carta Magna.

Mutatis, mutandis, precedente desta relatora em caso análogo, processo nº 5087415-92.2022.4.02.5101.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão a quo na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).